EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92296
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-07 10:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NELSON RAMON FIGUEROA FONSECA			RUN	: 6.536.312-7
F.Nac	: 23-06-2024	Edad	: 0 AÑO, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-27	Fecha Egreso	: 2024-09-07 10:31:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Multiescarado
-Postrado
-Enfermedad de Alzheimer
-Upp Glutea y talón Izquierdo.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE RECIENTEMENTE EGRESADO POR CUADRO INFECCIOSO RESPIRATORIO TIPO BRONQUITIS , ES TRAIDO POR FAMILIARES POR TOS PRODUCTIVA, FIEBRE E HIPOREXIA ACOMPAÑADO DE COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL. RX DE TORAX SIN IMAGENES DE CONSOLIDACION NI DERRAME
PCR 159 GLIC 171 CREAT 0.60 ELP 137/4.5/99 LEUC 9500 HB 10
INGRESA SUBFEBRIL, CON HEMODINAMIA ESTABLE, DISNEA LEVE SIN UMA, NORMOSATURANDO AMBIENTAL, CON TOS HUMEDA
CARDIOPULMONAR: MP+ CON RONCUS DISPERSOS BILATERALES. RSCSRS NAS
ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO. RH +
EXTREMIDADES: ATROFICAS, TALON IZQ CUBIERTO CON APOSITOS LIMPIOS

PACIENTE HOY 10 DIAS DE HOSPITALIZACION, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, AFEBRIL, TOS ESCASA HUMEDA. SE SOLICITA CONTINUAR TRATAMIENTO EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA.
ACTUALMENTE CON EXÁMENES DE LAB. Recuento de leucocitos : 7,30 mil/ul 3,60 - 10,20, Recuento Hematies : 3,60 * Mill/ul 4,50 - 5,90, Hematocrito : 32,1 * o/o , Albumina : 3,3 * g/dL, Creatinina : 0,60 * mg/dl, Clearence Calculado(MDRD) : 129,64 ml/min/1,73, Lactato : 0,8 mmol/L Proteina C Reactiva : 43,9 * mg/L, Uremia : 23 mg/dl.
SE CONVERSA CON FAMILIAR SOBRE CONDICIONDE POSTRACION DE PACIENTE, SIN REQUERIMIENTO DE OXIGENO, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CON PARAMETROS INFLAMATORIOS EN DESCENSO. SE SOLICITA CONTINUAR TRATAMIENTO EN HODOM.

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR TRATAMIENTO EN HODOM POR 10 DIAS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido.
2. Regimen POR SNG + agua libre 250 cc
3. Curacion de UPP dia por medio

4. KNT motora y respiratoria UNA VEZ al dia
5. CEFTRIAXONA AMP 2 GR EV
6. BROMURO DE IPATROPIO 4 PUFF CADA 6HRS
7. SALBUTAMOL INHALADOR 2PUFF CADA 8HRS
8. PREDNISONA COMP 20 MG X DIA
9. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS X DIA
10. PARACETAMOL COMP 500 MG 2 COMP CADA 8H
11. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS X NOCHE
12. MEMANTINA 10MG 1 AL DIA VO

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXÁMENES DE LAB. Recuento de leucocitos : 7,30 mil/ul 3,60 - 10,20, Recuento Hematies : 3,60 * Mill/ul 4,50 - 5,90, Hematocrito : 32,1 * o/o , Albumina : 3,3 * g/dL, Creatinina : 0,60 * mg/dl, Clearence Calculado(MDRD) : 129,64 ml/min/1,73, Lactato : 0,8 mmol/L Proteina C Reactiva : 43,9 * mg/L, Uremia : 23 mg/dl.

LUIS MERA SALTOS
MEDICO TRATANTE
21510269-6

JEFE SERVICIO